

5. Datenfelder komplett (inklusive Plausibilitäten und Abhängigkeiten)

DIV-HOTFALLEINSA-TZ-DATENSATZBESCHREIBUNG 7.1 MIND 7.1										Release 1: 28.08.2025	
DIV-HOTFALLEINSA-TZ-DATENSATZBESCHREIBUNG 7.1 MIND 7.1	Pflicht (wenns beugen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach Ein	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Tabelleinsatz Notarzt (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND	
Basis: Standardwerte											
Protokolltyp	Ja	Strukturierten	Dokument-Header	DIV	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Typ des verwendeten Protokolls. NA für Notarztstandard RD für Rettungsdienststandard Sollte in Stammdaten fest dem Rettungsmittel/Personal zugewiesen werden. Beim Wechsel von Dokumentations-Paas zwischen Fahrzeugen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das korrekte Rettungsmittel mit der ihm zugeordneten Projekt-ID und der richtigen Protokolltyp ausgewählt sind.	Wenn Protokolltyp nicht 000000		
Standortkennung	Nein	Strukturierten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Ärztlicher Gemeindefachdienst des RM-Standortes B.L.K.(Bundesland/Landkreis/Rettungswache/ Bundesland und Landkreis jeweils nach Vorgaben des Gemeindefachdienstes)	NA + RD	Ärztlicher Gemeindefachdienst des Rettungsmittels-Standorts.		2	
ProjektID	Ja	Strukturierten		M	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Standortbezogene Nummer, die von einer anderen Stelle vergeben und verwaltet wird. Standortverknüpfung muss aufgefordert, sich um eine ID-Zuteilung zu bemühen. Einmalig in Stammdaten einzufügen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. Leitzahl, Einsatzort, Rettungsmitteltyp, Protokolltyp		
Leitzahl	Ja	Strukturierten	Polsternummern	DIV	E	Landkreisnummer der Heimatblatts (z.B. S für Stuttgart, OD für Oberbayern)	NA + RD	Für einen Standort immer konstant und sollte automatisch beim Export zugeordnet werden. Einmalig in Stammdaten einzufügen.	Prüfung auf Plausibilität, z.B. ProjektID und Leitzahl		
Dokumentierung	siehe Hinweis/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	Strukturierten		M	E	Kennung des Dokumentationssystems des Rettungsmittels und die Software-Version	NA+RD	Identifikation des Dokumentationssystems und der Software-Version, mit der die Einsatzdaten erzeugt werden.	Prüfung in BW	2	
EMERGENCY	Nein		Polsternummern	D	E	Das ist nach Zustellung des Rettungsmittels in Leitstelle/Standort bzw. nach Projekt festzulegen Zustand: 01		Je nach Bundesland / Rettungsdienststandort festgelegtes eindeutiges Kennzeichen des Einsatzes.	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
PLZ	Nein		Polsternummern	D	E	Feld, in dem Zustellung des Rettungsmittels zu Anwendungsort bzw. nach Projekt festzulegen Postleitzahl 01		Je nach Bundesland / Rettungsdienststandort festgelegtes eindeutiges Kennzeichen des Patienten.	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
AuftragID	Nein		Polsternummern	D	E	Feld, in dem Zustellung des Rettungsmittels in Leitstelle/Standort bzw. nach Projekt festzulegen Auftrag: 01		Je nach Bundesland / Rettungsdienststandort festgelegtes eindeutiges Kennzeichen des RD-Auftrages.	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
Kategorie: Rettungsdienstleistungen Personen: Geschlecht	Ja	Rettungstechnisch/Daten		M	E	Einzelcode: Primärschichtcode für alle Fälle pro Jahr Zustimmung: 20	NA + RD	Einzelcode: Primärschichtcode für jeden Patienten Einmalig eine Leistung einer Person darf in einem Patienten kein Primärschichtcode mehrfach vergeben werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass im NA-Protokoll die NA-Auftragsnummer und im RD-Protokoll die Auftragsnummer verwendet wird! Bei mehreren Patienten in einem Einsatz, soll die der "Heimatschicht" für jeden Patienten eine separate Auftragsnummer zugewiesen werden. Diese ist ggf. anzufügen. Dort wo dies lokalisiert übertragungsseitig nicht möglich ist, soll der Primärschichtcode im jeweiligen Datensatz durch ein eindeutiges Suffix gekennzeichnet werden (bspw. Auftragsnummer der Leitstelle ergänzt mit -01 bis -99 oder mit -A bis -Z)	Wenn Kapitel in immer Pflicht		
EinsatzID	Ja	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Für die RD-Einsatzdatenformaten Für die Auswahl des zugeordneten Codes ist der Status zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden Rettungsmittels durch das Rettungsmittel festzulegen. (z.B. in einem NA-Protokoll dürfen unter EinsatzID nur Ausprägungen mit dem Inhalt "not" (gültig anwesender) NA dokumentiert werden, auch wenn der NA-Rettungsdienst und die primäre Alarmierung der RTW eine NA erfolgt im RD-Protokoll dürfen - sofern bei Alarmierung des RTW (noch) keine Alarmierung eines NA/NA erfolgt ist - unter EinsatzID nur Ausprägungen mit dem Inhalt "eine NA" dokumentiert werden, auch wenn es später zu einer NA- Nachforderung kam.) Einsatzdaten "not" (gültig anwesender) NA" (01, 05, 07) bzw. "not", "NA"-02, 03, 06, 07) sind immer dann auszuwählen, wenn bis zum Zeitpunkt der Alarmierung des dokumentierenden RM ein NA oder ein TNA ebenfalls alarmiert wurde. Derzeit und Phase sind organisatorische Einsatzdaten, die in keinem Bezug zu einem bestimmten oder unbestimmten Patientenkonzept stehen (beispielsweise Patient in die RD-Werkstatt). Ein Materialtransport, für den ein Patientenbezug hergestellt werden kann (z.B. Transport eines Inhabitors durch einen RTW zu einem anderen Einsatz) ist nicht mit diesem zu kodieren. Wenn ein RTW von der Leitstelle einen Krankentransportauftrag erhalten hat, ist als EinsatzID Krankentransport auszuwählen. Codes 05-12 nicht im DIV1 Protokoll abgebildet	Für Datenlieferung für Dokumentation und Plausibilitätsprüfungen. Wenn Protokolltyp NA, dann ist EinsatzID GLEICH (04 ODER 08 ODER 10) unzulässig		
Gemeindefachdienst	Nein	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Ärztlicher Gemeindefachdienst des Einsatzortes	NA + RD	Quelle ist das Städtische Gesundheitsamt. Der Ärztliche Gemeindefachdienst (AGD) ist ein 8-stufiger Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung einer Gemeinde mit dem Bundesland (2 Stellen), Regierungsbezirk (1 Stelle), Kreis (2 Stellen) und Gemeinde (2 Stellen)		2	
Postleitzahl	Nein	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	PLZ des Einsatzortes - Sowie bei Einsatzort am Wohnort des Patienten zuzusatz der Versicherungsstelle zu entnehmen		2	
GeoEinsatzort	Nein	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Geokoordinaten des Einsatzortes	NA + RD	Die Koordinaten werden in der Reihenfolge Breitengrad, Längengrad mit Komma getrennt angegeben. Format: 99.999999 99.999999	Pflicht wenn: Einsatzort NA/CHT (11 ODER 12)	2	
EinsatzortTyp	siehe Hinweis/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Beschreibung des Einsatzortes Pflicht, außer für Dienstfahrten und Passageninsätze	Pflicht wenn: Einsatzort NA/CHT (11 ODER 12)	2	
Rettungsort	siehe Hinweis/ Plausibilitäten/ Abhängigkeiten	Rettungstechnisch/Daten	Dokument-Header/Datei	DIV	E	Verfälscht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Welcher Rettungsmittel hat den überwiegenden Anteil des Transports des Patienten (insbesondere für Transportnachschub beachtlich) Transport durch NAVI ist nur auszuwählen, wenn es sich bei dem RM von vornherein um einen NAVI gehandelt hat (sein RTW, bei dem der NA den Transport begleitet, bildet ein RTW) Bei gemeinsamen Einsatz von RTW und NA identische Dokumentation in RD- und NA-Protokoll Pflicht, außer für Dienstfahrten und Passageninsätze	Für Datenlieferung für Dokumentation und Plausibilitätsprüfungen. Bei Auswahl 01 wird kein TranspAnPaz zum Pflichten Bei Auswahl 02 wird kein TranspAnPaz zum Pflichten Pflicht wenn: Einsatzort NA/CHT (11 ODER 12) Wenn Einsatzort GLEICH (11 ODER 12), sind sämtliche Inhalte in RDTransport auf der 2 unzulässig	2	

DIV-NOTFALLENSATZ-DATENATZESCHREIBUNG 1.1 MIND-DATENATZESCHREIBUNG 1.1 Zusatzfelder in einer Spaltenbreite (z.B. Einzeile) sind ausschließlich für das DIV-Nachkennzeichnungsprodukt relevant	Pflicht (gibt an, ob das Feld auf das zugewordene Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach EM	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teilbereich Nurcode (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pflichtsituation/Abhängigkeiten	techn. Detail MIND
Symptombeginn/Verzögerung	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Beobachtet die Symptome länger als 24 Stunden oder ist Sie unbekannt? Werteliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Pflicht für NA-Protokolle bei Primäreinsätzen, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesbesetzung (ohne CPR) oder eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle bei Primäreinsätzen ohne erkennbare Beteiligung eines physisch anwesenden NA, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine primäre Todesbesetzung (ohne CPR) oder eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH (01 ODER 03) UND KeinTranspMSPH NICHT (02 ODER 05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (11 ODER 13 ODER 14 ODER 15 ODER 16 ODER 17 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND EinzeileNA GLEICH (02 ODER 14) UND Nachschickgefordert GLEICH 02 UND KeinTranspMSPH NICHT (02 ODER 15 ODER 98)	-2
Symptombeginn	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Ereigniszeitpunkt, Unfallzeitpunkt, Kollisionszeitpunkt, Zeitpunkt Symptom-/Beschwerdebegrüßung	NA + RD	Wenn der Symptombeginn bzw. Unfall-/Ereignis-/Kollisionszeitpunkt (bekannt oder geschätzt) innerhalb von 24 Stunden vor Alarmierung liegt, ist die Uhrzeit hier anzugeben.	Pflicht wenn: SymptombeginnVorfall GLEICH 05 UND EinzeileNA NICHT (11 ODER 12)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Symptombeginn/Geschlecht	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	ist der Symptombeginn geschlecht oder geschätzt?	NA + RD	001 ist isoliertes Angaben zum Symptombeginn durch Patienten, Angehörige, Zeugen, etc.?	Pflicht wenn: SymptombeginnVorfall GLEICH 02 UND EinzeileNA NICHT (11 ODER 12)	-2
Schlagablenkung	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	M	E	Zeitpunkt Eingangs Notfallschleife an LST	NA + RD	Pflicht, wenn Symptombeginn innerhalb der letzten 24 Stunden. Definition: Zeitpunkt des Anrufes (Kutschzeitpunkt aus Leitstellen-Datenatz) Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Alarmfunktionsübergabe	NA + RD	Definition: Auslösung Alarm durch LST Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarmzustand	Nein	Ja/Nein/Entfällt		M	E	Zeitpunkt Alarmfunktions-Status Status 3	NA + RD	Definition: Auslösen des ersten Alarmen Rettungsmittels (Bezeichnung komplett) Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm/Ankunft Einsatzort	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Ankunft Einsatzort Status 4	NA + RD	Definition: Ankunft des dokumentierten RM am Einsatzort. Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Alarm/Patientenkontakt	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Ankunft Patient	NA + RD	Definition: Ankunft der Rettungsmittelbesatzung beim Patienten bzw. Beginn der Übernahme des Patienten bei Sekundäreinsatz. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um einen Krankentransport oder um eine Hilfestellung oder die Unterstützung eines anderen RM handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 98) UND KeinTranspMSPH NICHT (05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 13 ODER 14 ODER 15 ODER 16 ODER 17 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND NichtEinzeileNA GLEICH 10 ODER KeinTranspMSPH GLEICH (15 ODER 98)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitTransportbeginn	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Transportbeginn Status 7	NA + RD	Definition: Beginn des Patiententransportes. Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitEinfahrtTransportziel	Nein	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Eintreffen Transportziel	NA + RD	Definition: Fahrzeug tritt am Transportziel ein Wird in der Labelele dokumentiert.		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitÜbergabePatient	siehe Hinweise/ Pfleblätter/ Abhängigkeiten	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Übergabe des Patienten an Weiterbehandler	NA + RD	Definition: Übergabe an Personal der Zielklinik/Praxis oder Übergabe an anderes Rettungsmittel (Übergang der Verantwortung für den Patienten). Bei Einsatz ohne Patiententransport optional als Abschluss der Behandlung. Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat (Übergabezeitpunkt an Klinik bzw. an anderes transportierendes RM, wenn dokumentierende NA den Transport nicht begleitet). Pflicht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport durch das dokumentierende RM stattgefunden hat und keine medizinische Begleitung erfolgt bzw. die Begleitung ausschließlich durch einen TNA durchgeführt wurde.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 18 ODER 19 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 15 ODER 16 ODER 17 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND Auszeitbegleitet ENTHALT (03 ODER 03) UND Auszeitbegleitet ENTHALT NICHT (01 ODER 02 ODER 04 ODER 05 ODER 98)	1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
ZeitEinsatzende	Ja	Ja/Nein/Entfällt	Erstrettschicht	DM	E	Zeitpunkt Einsatzende	NA + RD	Definition: Einsatz ist abgeschlossen (RM) oder mit dem Einsatz zusammenhängenden Arbeiten wie z.B. Deaktivationsstätigkeiten und Dokumentation)		1992-05- 07T22:06 00.000+ 01:00
Kapitel: Patientenenden								Pflicht für NA-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich um eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn der Patientenkontakt stattgefunden hat, außer wenn es sich beim dokumentierenden Rettungsmittel um einen Krankentransport, eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsmittels handelt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND RDTransport GLEICH (01 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND KeinTranspMSPH NICHT (05 ODER 98) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (01 ODER 13 ODER 14 ODER 15 ODER 16 ODER 17 ODER 18 ODER 19 ODER 98) UND NichtEinzeileNA GLEICH 10 ODER KeinTranspMSPH GLEICH (15 ODER 98)	

DIN-MULTIMEDIALE DATENSATZZEICHENBUND 1.1 WIND-DATENSATZZEICHENBUND 1.1 Beschrieben in einer Software (z.B. PowerPoint oder ausschließlich für den DIN-Multimedialeinsatz relevant)	Pflicht (eventuell bezogen auf das jeweilige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehöriges DIN-MIND	Einfluss/ Einfluss DIN	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teilmerkmal Notiert (NA Bezeichnung) (ID)	Erläuterungen	Hinweise/Platzhalter/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Zureichlichkeit	Ja			M	E	Einordnung der zeitlichen Örtlichkeit durch Transparenz Werkzeuge siehe Tabellentitel Codes	NA	Wenn Kapitel "Einordnung/Verknüpfung" Pflicht, dann ist Code 00 unzulässig.		-2
Induktion?	Ja			M	M	Induktion Induktionsort Werkzeuge siehe Tabellentitel Codes	NA	Sehe Experimente zu Option "Sonstige" Die Antwort NEIN ist implizierbar, wenn im Kapitel "Entstehungs/Verknüpfung" zusätzlich eine Bezeichnung als auch eine Kategorisierungsfähigkeit dokumentiert sind Wenn Kapitel "Einordnung/Verknüpfung" Pflicht, dann ist Code 00 unzulässig. Wenn Kapitel "Einordnung/Verknüpfung" Pflicht, dann ist Code 00 unzulässig. Kombinationen mit 00 sind unzulässig. Notiert sein: Freiwillig GLEICH NA UND Notwendig GLEICH 01 ODER 02 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 10 UND KeinTransparenz/Nicht (00 ODER 01 ODER 02) ODER Heraus für BW: Wenn ein Diagramm, so die ein Indikator zur Eignung der Zeitlinie oder zur zeitlichen Einordnung Verknüpfung dieser Diagramme werden, im Diagramm nicht dokumentiert, ist, soll auch eine entsprechende geeignete Zeitlich und thematische Verknüpfung werden. Eine unvollständige Differenzialdiagnose oder ein Fall dokumentiert werden. Freiwillig GLEICH 00 UND Notwendig GLEICH 01 ODER 02 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 10 UND KeinTransparenz/Nicht (00 ODER 01 ODER 02) UND Notwendig/Nicht GLEICH 02 UND Erweitert GLEICH 02 ODER 03 ODER 04 ODER 05		-2
Kapitel Diagnose										
Diagnose	Ja	Diagnose	Erkrankungen	DM	M	Nachschubdiagnose Werkzeuge siehe Tabellentitel Codes	NA + RD	Hier sollen nur eindeutige Diagnosen und keine Vorerkrankungen dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht oder 1813 + SOS oder werden. + einer Analyse-Gloss 4 ist zusätzlich die Diagnose 1220 + Not-Krankheits-Schicht dokumentiert werden. + (Verdachts-)Diagnose der Notfallschicht Notizen bzw. der Notfallschicht/Notfallschicht Verdachts- oder Patienten-Formen können mit 1220 + Not-Krankheits-Schicht		

DIN-NOTFALLENSATZ-DATENSATZBESCHREIBUNG 7.1 Beschreibung in einer Darstellung (z.B. Einseitigkeit) und ausschließlich für den DIN-Merkmalenvergleich relevant	Pflicht (eventuell bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugänglichkeit (DIN-4842)	Einfach- führfähig E/F	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Tabellensatz Notiert (NA) Rettungsdienst (RD)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Default MIND
Zugänglichkeit	Nein	Medikation	Medikation	D	M	Zahl, Formel etc.		Anzahl von Dokumentenblättern geladene Zugänge eingetrag	gemeinsame Wertespere	
Zugangscode	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Wurde/steht zum beschriebenen Unfallschadungszugang	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienung	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Wurde/steht zur Art der Bedienung	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl		maximaler Ca-Konzentration bei Bedienung während des Einsatzes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl		Maximale Atemfrequenz bei Bedienung (passiviert oder kontrolliert) während des Einsatzes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl, Litar		Maximale Atemfrequenz bei Bedienung während des Einsatzes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl, mdr		Maximaler Spitzendruck bei Bedienung während des Einsatzes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	M	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Wurde/steht für die Art der eingesetzten Verfahrenstechnik	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Angabe von Daten und Uhrzeit		Kategorie der ersten Schockspiegelung	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl, Formel etc.		Anzahl der abgegebenen Schläge (Kardiotomem plus Defibrillation)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Bedienungsfeld	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl, Formel etc.		Maximale Energie der abgegebenen Schläge	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	M	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Weitere durchgeführte Maßnahmen	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Lagerungsposition (wie: eingewickelt, Lagerungspositionen)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zahl, Formel etc.		Anzahl eingesetzter Spritzenabgaben	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zeit, Zwischenzeit 200		Weitere eingesetzte Maßnahmen, die in den Vorfeldblättern und Feldern im Maximalmer-Kapitel nicht eingetragen sind	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug Teil	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Zeit, Zwischenzeit 200		Modifikation, die im Rahmen der Durchführung helfender Maßnahmen vom Rettungsdienst ohne Arzt gegeben wurde	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Kapitel: Medikamentöse Therapie								Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Totenbeurteilung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsdienstes handelt Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport oder eine primäre Totenbeurteilung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsdienstes handelt oder ein physisch zusammen für einen Patienten oder mehrere Patienten	Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um eine primäre Totenbeurteilung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsdienstes handelt Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat - außer wenn es sich um einen Krankentransport oder eine primäre Totenbeurteilung (ohne CPR), eine Hilfestellung oder eine Unterstützung eines anderen Rettungsdienstes handelt oder ein physisch zusammen für einen Patienten oder mehrere Patienten	
Medikation/Werkzeug	Ja	Medikation/Werkzeug	Medikation	DM	M	Medikamentencodes für Art des Medikaments und Applikationsweg	NA + RD	Nur einzelnverpackte Medikamente dokumentieren. Auch eine Vorbehandlung durch Andere soll dokumentiert werden, da diese für verschiedene Indikationen relevant sein kann (für jede Medikamenten-Gruppe separat dokumentierbar)	Wenn Kapitel "Medikamentöse Therapie" Pflicht, dann ist -2-unzulässig Kombinationen mit 999999 sind unzulässig	-2
Infusion/Werkzeug	Ja	Medikation/Werkzeug	Medikation	DM	M	Medikamentencodes für Art der Infusion und Applikationsweg	NA + RD	Nur einzelnverpackte Medikamente dokumentieren Dauermedikation und Verdünnung durch Andere (Hausarzt, andere Rettungsdienst etc.) mit 700	Wenn Kapitel "Medikamentöse Therapie" Pflicht, dann ist -2-unzulässig Kombinationen mit 999999 sind unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	M	Zeit, Zwischenzeit 20		Dosis der Medikamentengabe (inklusive Eintrag)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	M	Zeit, Zwischenzeit 20		Menge der Medikamentengabe (inklusive Eintrag)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes 2001		Wurde/steht	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Medikation/Werkzeug	Nein	Medikation	Medikation	D	E	Angabe von Daten und Uhrzeit		Datum und Uhrzeit - wenn Transportbegleitung nicht bekannt hat	Für MIND-Datensatz: Feld nicht überfällbar; Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen	
Kapitel: Abschlusshilfsleistung								Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat und der Transport nicht durch einen physisch zusammengefassten Rettungsdienst begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt	Prüfung für RD-Protokolle, wenn ein Patientenkontakt stattgefunden hat und der Transport nicht durch einen physisch zusammengefassten Rettungsdienst begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt	
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitenreflexen bessere Seite	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bei Seitenreflexen bessere Seite	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	M	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wurde/steht zur Dokumentation von Schweregraden und der Körperweite ist im MIND nicht vorgesehen	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Bedeutet RM-Messung durchgeführt; wenn Angabe im Vorfeldbereich oder 999	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	M	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Sollten bei Erhebung der Abschlusshilfsleistung mehrere Befunde zutreffen, ist eine Mehrfachangabe möglich (hier sollen keine Ausprägungen dokumentiert werden, die vorher im Verlauf des rettungsdienstlichen Einsatzes zutreffend waren und nicht mehr vorhanden sind)	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Für 05 wird EXG als durchgeführt gewertet, wenn Angabe ungleich -1	Kombinationen mit -1 oder 99 sind unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Vom Monitor abgelesene Herzfrequenz pro Minute (ggf. palpatorisch oder pulsstetisch beatmetete Pulsfrequenz, wenn kein EXG abgelesen wurde)	Wenn Kapitel "Abschlusshilfsleistung" Pflicht, dann ist -2-unzulässig	-2
Medikation/Werkzeug	Ja	Abschlusshilfsleistung	Infusion/Werkzeug	DM	E	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Wurde/steht siehe Tabellenblatt Codes	Wenn EXG-Befund GLEICH 0, dann sind Werte GRÖßER 0 unzulässig	-2

DIV-NOTFALLEINSAZ. DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 MIND-DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 Zustandset in einer Standard-ID (z.B. Einsatzort) sind ausschließlich für das DIV-Merkmalzusatzprodukt relevant	Pflicht (je falls bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ansprüchung	MIND- Teilstatensatz Notiert (NA, Rettungsdienst RD)	Erläuterungen	Hinweise/Pausibilitäten/Abhängigkeiten	techn. Status MIND
SOCCWort	sehr Hinweis/ Pausibilität/ Abhängigkeiten			M	E	SOCC Wort (Wort) unter Bedingung in meiste (gemessen) Wertliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Besteht Vorgehensweise durchgeführt, wenn Angabe im Widerspruch oder 999 Pflcht wenn Atemwegsicherung oder maschinelle invasive Beatmung (unterstützt oder kontrolliert) dokumentiert.	Pflcht wenn: Atemweg GLEICH (03 ODER 05 ODER 07) ODER Atemweg GLEICH 05 Wenn SOCCWort Pflcht, dann ist -2 unzulässig	-2
Kapitel: Zielstink								Pflcht für NA-Protokolle, wenn es sich bei den dokumentierenden Rettungsmitteln um ein beseitigendes notwendiges Rettungsmittel handelt, ein Patiententransport stattfindet und der Patient den Transport begleitet oder die RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflcht für NA-Protokolle, wenn es sich bei den dokumentierenden Rettungsmitteln um ein aufgebundenes notwendiges Rettungsmittel handelt, ein Patiententransport stattfindet und der Patient den Transport begleitet oder die RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflcht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch bewegenden Patient, sondern ausschließlich durch einen Transport begleitet wird	Pflcht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DuatRM GLEICH (04 ODER 04 ODER 07 ODER 10) UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DuatRM GLEICH (05 ODER 05) UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 08)	
NummerZK	Ja	Zielstink		M	E	Kenntung der Zielstink Wertliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Standortnummer nach §20 Absatz 6 SGB V aus dem bundesweiten Verzeichnis der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen Falls nur die Standort-ID bekannt ist (r erste 6 Stellen der Standortnummer) ist diese nach der 6. Stelle mit "0" (Null) auf 6 Stellen aufzufüllen. Standortnummer (Zielstink/Themen) oder Standort-ID-Bestell- 77mm000) der Zielstink. Einmalige Angabe oder regelmäßig angeforderten/angeforderten Krankenhäuser der Akutenversorgung in Standarddaten erforderlich. Für Einrichtungen ohne Standortnummer müssen auf örtlicher Ebene alternative Definitionen getroffen werden.	Wenn Kapitel "Zielstink" Pflicht, dann ist -2 unzulässig	-2
AnmeldungPatient	sehr Hinweis/ Pausibilität/ Abhängigkeiten	Zielstink	EinsatztechnischeDaten	DM	E	Wurde der Patient in der Zielstink angemeldet? Muss bei Patiententransport angegeben werden, auch wenn die Anmeldung durch die Leitstelle erfolgt. Wertliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Patientenmeldung durch Fahrgastgesetzgebung oder Leitstellenpersonal Mindestens einmal pro Patient erforderlich. Pflcht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattgefunden hat, der durch den dokumentierenden NA begleitet wurde. Pflcht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch bewegenden Patient, sondern ausschließlich durch einen Transport begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Wenn Kapitel "Zielstink" Pflicht, dann ist -2 unzulässig Pflcht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DuatRM GLEICH (01 ODER 04 ODER 07 ODER 10) UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit GLEICH 01 ODER Protokolltyp GLEICH NA UND DuatRM GLEICH (05 ODER 05) UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit GLEICH 02 ODER Protokolltyp GLEICH RD UND RDTransport GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08 ODER 09 ODER 08) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03) UND AerttBegleit ENTHALT (03 ODER 03 ODER 04 ODER 05 ODER 08) UND EinsatzArt NICHT 10	-2
AnmeldungZK	Nein		EinsatztechnischeDaten	D	E	Wertliste siehe Tabellenblatt Codes ZK1		Wertliste zur speziellen Ressource des Krankenhauses, die eine spezifische Voranmeldung erfordert	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
AnmeldungZK1	Nein		EinsatztechnischeDaten	D	E	Wert. Zeichenkette 200		Speziellen Ressourcen des Krankenhauses, die eine spezifische Voranmeldung erfordert aber in der zugehörigen Liste nicht aufgeführt ist	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Transport	Nein		EinsatztechnischeDaten	D	E	Fest. Zeichenkette 200		Name des Transportmittels, ggf. mit Adresse	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
Kapitel: Einsatzbesonderheiten									Pflcht wenn: Einsatzort NICHT (11 ODER 10)	
Einsatzbesonderheiten	Ja	Einsatzbesonderheiten	Einsatzverlauf + Bemerkungen + Einsatztechnische	DM	M	Einsatzbesonderheiten Wertliste siehe Tabellenblatt Codes	NA + RD	Abweichung von medizinischen Standards, Abweichung vom Zielstink, r erhöhter Aufwand. Abklärung individueller Maßnahmen (z.B. Diagnostik, Therapie) durch Patienten - 02 Transportwegweisung ist ein Fall-KanTransMMPat zu dokumentieren (JA + Patient lehnt Transport ab) Pflcht, außer für Dienstfahrten und Pausenintervalle	Kombinationen mit 00 sind unzulässig	-2
PharmazieStatus	Nein	Einsatzbesonderheiten	Notfallgeschichten	DM	E	Wertliste siehe Tabellenblatt Codes ZK1	NA + RD	Schwere der Vorerkrankungen, Zustand vor Eintritt des Notfalls Pflcht für NA-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Patient den Transport begleitet oder die RTW den Transport ohne ärztliche Begleitung durchführt. Pflcht für RD-Protokolle, wenn ein Patiententransport stattfindet und der Transport nicht durch einen physisch bewegenden Patient, sondern ausschließlich durch einen Transport begleitet wird und es sich nicht um einen Krankentransport handelt.	Pflcht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Diagnose ENTHALT (1220 ODER 1810) ODER KantTransMMPat GLEICH (02 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND Diagnose ENTHALT (1220 ODER 1810) ODER KantTransMMPat GLEICH (02 ODER 03) UND EinsatzArt GLEICH (03 ODER 04 ODER 05 ODER 08)	-2
Kapitel: Reanimation										

DIV-HOTFALLEINSAZ: DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 WIND-DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 Benutzt werden in einer Normdatei (z.B. Einsatzplan) sind ausschließlich für das DIV-Kriterienkriterienkriterien relevant	Pflicht (je falls bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach/ Mehrfach E/M	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teilensatz Notizen (NA, Rettungsdienst RD)	Erläuterungen	Hinweise/PausibilisierungsAnforderungen	techn. Status MIND
Reanimationssituation	Ja	Reanimation	Reanimation	M	E	Wurde eine Reanimation durchgeführt? Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Eine dokumentierte Reanimation ist mit E1 oder E2 oder E3 zu dokumentieren. Bei primärer Totkeimbefragung (ohne CPR) ist nur "Reanimation nicht durchgeführt." zulässig. Ohne Patientenkontakt ist nur "keine Reanimationssituation (kein Totkeimbefragung)" zulässig. Bei Diagnose Herz-Kreislauf-S Stillstand oder SIDS bzw. bei Dokumentation "Patient im Einsatzzeitpunkt verstorben" ist "keine Reanimationssituation (kein Totkeimbefragung)" zulässig.	Hinweise für Dokumentationsanforderung und PausibilisierungsAnforderungen Wenn KeinTransportMMPat GLEICH 02, dann ist Reanimationssituation GLEICH 00 ODER 01 ODER 02 ODER 03 ODER 04 unzulässig. Wenn RDTransport GLEICH 02, dann ist nur Reanimationssituation GLEICH 00 zulässig. Wenn Diagnose ENTHALT (1200 ODER 1813) ODER KeinTransportMMPat GLEICH 03 dann ist Reanimationssituation GLEICH 00 unzulässig.	-2
Kapitel: ReanimationDetails								Pflicht für NA-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmitglied Reanimation durchgeführt hat und eine Notfalloption ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt. Pflicht für RD-Protokolle, wenn dokumentierendes Rettungsmitglied Reanimation durchgeführt hat und eine Notfalloption ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 01 ODER 02 ODER 03) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 01 ODER 02 ODER 03) UND Einsetzen GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08) UND Nachforderung GLEICH 02	
Reanimationstechnik	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	M	Verfahre siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD		Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig. Kombinationen mit -1 sind unzulässig.	-2
UNREST	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Vermutete Ursache des Kreislaufstillstandes Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Die internationalen Vorgaben des Utstein-Styls Protokolle unterscheiden die Ursachen eines Kreislaufstillstandes in mehreren Sektionen. Gehört ist die aus Sicht des Notarztes vermutete Ursache.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
SPORT	Nein	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zusammenhang mit sportlicher Aktivität Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Beschreibt ein Zusammenhang des Kreislaufstillstandes mit sportlicher Aktivität?	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOFR	Nein	ReanimationDetails	Notfallgerichten	DM	E	Zeitpunkt Eintrifft First Response Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Eintrittszeit eines First Responders als "Vorwissen" neben dem regulären Rettungsdienst am Einsatzort.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
EXIS	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Kolaps beobachtet? Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat den Kolaps beobachtet? Entfaller entspricht dem nichtmedizinischen Personal bzw. Laien.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEM	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Herzdruckmassage begonnen Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat mit der Herzdruckmassage begonnen bzw. den Beginn angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu dokumentieren)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEF1	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Person Defibrillation durchgeführt Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Wer hat die erste Defibrillation durchgeführt bzw. angeordnet? (Es ist die jeweils am höchsten qualifizierte anwesende Person zu kodieren.)	Wenn Protokolltyp GLEICH NA UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann ist 06 unzulässig. Wenn Protokolltyp GLEICH RD UND Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind 05 ODER 06 unzulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 00, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
DOEM	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt Beginn Herzdruckmassage Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Erster Zeitpunkt, zu dem mit der Herzdruckmassage begonnen wurde, ggf. schätzen.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
DOEF1	siehe Hinweise/ PausibilisierungsAnforderungen	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt erste Defibrillation Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Zeitpunkt der ersten Defibrillation. Pflicht für NA-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW, RTW oder NA dokumentiert wurde. Pflicht für RD-Protokolle, wenn eine Defibrillation durch den KTW oder RTW dokumentiert wurde und eine Notfalloption ohne erkennbare NA-Beteiligung bzw. Nachforderung vorliegt.	Pflicht wenn: Protokolltyp GLEICH NA UND DOEF1 GLEICH 04 ODER 05 ODER 06) ODER Protokolltyp GLEICH RD UND DOEF1 GLEICH 04 ODER 05) UND Einsetzen GLEICH 02 ODER 04 ODER 06 ODER 08) UND Nachforderung GLEICH 02 Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
DOESC1	siehe Hinweise/ PausibilisierungsAnforderungen	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Zeitpunkt 1. ROSC Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Bei Wiederertritt eines Eigenkreislaufs (ROSC) ist die Zeit zu notieren. Ab diesem Zeitpunkt hat der Patient einen eigenen Kreislauf mit einem messbaren Puls. Auch wenn dieser wieder zusammenbricht (ROSC = nicht 4. spontaneus stabilisiert (Spontankreislauf)).	Pflicht wenn: ROSC GLEICH 02 Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
ROSC	Ja	ReanimationDetails	Massnahmen	DM	E	Erreichen eines Spontankreislaufs Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Konnte durch die Reanimationsmaßnahmen jemals ein spontaner Kreislauf > 30 Sekunden etabliert werden? Wenn bei KAUF "Krankheitsaufnahme mit ROSC", dann in Feld ROSC nur "jenseits ROSC" zulässig.	Wenn KAUF GLEICH 02, dann nur ROSC GLEICH 02 zulässig. Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
KALUF	Ja	ReanimationDetails	Reanimation	DM	E	Patientenzustand bei Krankheitsaufnahme Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes	NA + RD	Zustand bei Übergabe an die Zielklinik.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05, dann sind alle Werte außer -2 unzulässig.	-2
TDO	Nein	ReanimationDetails	Reanimation	DM	E	Zeitpunkt TDO Angabe von Datum und Uhrzeit	NA + RD	Beendigungszeitpunkt der Reanimationsmaßnahmen.	Wenn Reanimationssituation GLEICH 05 ODER 06 ODER 07 ODER 08, dann sind alle Werte außer "1902-02-02T22:00:00.000+01:00" unzulässig.	1902-03-02T22:00:00.000+01:00
ReanimationErfolg	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Wertefeld 0 und mit welchem Erfolg eine Reanimation erfolgte	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationFeedback	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Ja = Ein Feedbacksystem wurde eingesetzt, Nein = Es wurde kein Feedbacksystem eingesetzt, Leer = wie Nein	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationTafeln	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Ja = Tafelreanimation wurde eingesetzt, Nein = Tafelreanimation wurde nicht eingesetzt, Leer = wie Nein	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationBefehl	Nein	Massnahmen	D	E	Wertefeld siehe Tabellenfeld Codes 2001		Wertefeld, wenn eine Reanimation bei reanimationsfähigen Patienten nicht eingesetzt wurde	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		
ReanimationNotizenSonderg	Nein	Massnahmen	D	E	Text_Zusatztext 200		Notizen warum eine Reanimation bei reanimationsfähigen Patienten nicht eingesetzt wurde, wenn Wert in zugehöriger Wertefeld nicht enthalten ist	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermitteln. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.		

DIV-NOTFALLDATENSATZ: DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 MIND-DATENSATZSCHREIBUNG 1.1 Datenfelder in einer Spalte (z.B. Einzelwerte einer Personendatensatz für das DIV-Merkmalprotokoll relevant)	Pflicht (jeweils bezogen auf das zugehörige Kapitel)	MIND-Kapitel	DIV-Kapitel	Zugehörigkeit DIV-MIND	Einfach-/ Mehrfach EW	Bezeichnung Merkmal Ausprägung	MIND- Teildatensatz Notarzt (NA) Notrufgeleitete (RG)	Erläuterungen	Hinweise/Plausibilitätsabhängigkeiten	techn. Default MIND
ZusatzSonstige	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Vermutete Ursache des Kreislaufstillstands, wenn in der zugehörigen Webliste nicht angegeben	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
KollapsBedachtlosSonstige	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die den Kollaps bedachtlos hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
ReanimGefährliche	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die mit der Reanimation begonnen hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
ReanimGefährliche	Nein		Reanimation	D	E	Text_Zeichenbit 200		Angabe zur Person, die die erste Defibrillation durchgeführt hat, wenn in den zugehörigen Feldern nicht aufgeführt	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	M	Wertliste siehe Tabellenbit-Code-DIV		Wertliste zu Todeszeitpunkt und Ort des Todes	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	E	Wertliste siehe Tabellenbit-Code-DIV		Wertliste zur Todesursache	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
TodesUrs	Nein		Reanimation	D	E	Angabe von Datum und Uhrzeit		Kalender: Das Todes Ereignis (Freigabe durch Arzt der die ggf. vollständige oder endgültige Leichenschau macht)	Für MIND-Datensatz: Feld nicht übermittelbar. Abweichungen führen zu Abweisung von Datenlieferungen.	
NA										